

Ekspozycja w rzeczywistości *wirtualnej* (VRET)

Symulacja sytuacji fobii w okularach VR — równie skuteczna jak ekspozycja w realu, łatwiej dostępna i bezpieczniejsza.

CZAS SESJI: 20–45 min **SKUTECZNOŚĆ:** porównywalna z *in vivo*

ŹRÓDŁO: Carl i wsp. (2019); Rothbaum i wsp. (1995)

JAK UŻYWAĆ

VRET (ang. *Virtual Reality Exposure Therapy*) — ekspozycja na bodziec fobii w środowisku wirtualnym, z użyciem gogli VR. Pacjent „znajduje się” w sytuacji fobii (na wieży widokowej, w samolocie, w pomieszczeniu z pajakami) — ale fizycznie jest w gabinecie. Terapeuta steruje parametrami: wysokością, liczbą bodźców, intensywnością scenariusza.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Carl i wsp. (2019, meta-analiza 30 badań RCT): VRET jest **równie skuteczna** jak ekspozycja *in vivo* ($d=1,09$ vs $d=1,12$ — różnica nieistotna statystycznie). Mózg generuje *poczucie obecności* (ang. *sense of presence*) — reaguje fizjologicznie tak, jak na bodziec realny. **Przewagi VRET:** kontrola parametrów (np. precyzyjna wysokość, bezpieczeństwo, powtarzalność, dostęp do sytuacji trudnych do odtworzenia w realu (burza, lot, dziki pies). **Najlepiej zbadane wskazania:** lęk wysokości, fobia latania, lęk przed pajakami. VRET to *nie gra*, ale kontrolowane środowisko terapeutyczne.

01 VRET czy ekspozycja w realu — kiedy co wybrać

KRYTERIUM	VRET	EKSPOZYCJA IN VIVO
<i>Skuteczność</i>	Porównywalna ($d=1,09$); meta Carl i wsp. 2019.	Najlepiej zbadana ($d=1,12$); standard złoty.
<i>Dostępność</i>	Wymaga okularów VR (od ok. 300 zł) i oprogramowania.	Wymaga obecności realnego bodźca (lot, pies, wieża).
<i>Kontrola parametrów</i>	Pełna — precyzyjna wysokość, liczba pajaków, pogoda w locie.	Częściowa — pies może zachować się różnie, pogoda się zmienia.
<i>Najlepsze wskazania</i>	Latanie, wysokości, sytuacje niedostępne realnie, silne unikanie startu.	Zwierzęta (pies, pajak), winda, dentysta, codzienne sytuacje.
<i>Krok końcowy</i>	Często krok pośredni do <i>in vivo</i> .	Cel docelowy — spotkanie z realnym bodźcem.

02 Kiedy VRET jest szczególnie sensowna

BODZIEC NIEDOSTĘPNY

Burza, lot, dziki pies, miejsca odległe. W VR — dostępne na żądanie, w gabinecie.

WYSOKIE UNIKANIE STARTU

Lęk na samą myśl o ekspozycji w realu — SUDS >90. VR jako most do realnego kontaktu.

KOSZT EKSPOZYCJI IN VIVO

Lot kosztuje setki/tysiące złotych. Sesja VRET — 50–150 PLN. Można powtarzać częściej.

BEZPIECZEŃSTWO

Pacjent z chorobą serca lub po urazie — ostrożna ekspozycja kontrolowanym bodźcem zamiast od razu w realu.

03 Protokół sesji VRET — przebieg krok po kroku

ETAP	CO ROBISZ	CZAS	MÓJ ZAPIS
1 · <i>Oczekiwanie</i>	Pisemnie: „Co spodziewam się, że poczuję?” Pewność 0-100%.	5 min	
2 · <i>Wejście w scenariusz</i>	Założenie gogli, kalibracja. Najlżejszy scenariusz z hierarchii.	2-3 min	SUDS startowy: ____
3 · <i>Pogłębianie</i>	Pozostajesz w scenariuszu. Terapeuta stopniowo zwiększa intensywność (więcej pająków, wyższy balkon).	20-35 min	SUDS co 5 min: ____ → ____ → ____
4 · <i>Powrót</i>	Zdjęcie gogli, krótka rozmowa, porównanie oczekiwania z rzeczywistością.	5-10 min	SUDS końcowy: ____

04 → Co po VRET — krok pośredni, nie cel

VRET jest **najczęściej etapem przejściowym**, nie końcem terapii. Cel docelowy — spotkanie z realnym bodźcem, jeśli jest dostępne. Plan przejścia:

3-6 SESJI VRET

SUDS spada z 80-90 do 30-40.
Mózg uczy się: „w samolocie / na wysokości nic mi się nie dzieje”.

PIERWSZY KONTAKT W REALU

Lotnisko bez lotu · balkon w domu · mały pies pod opieką.
Świeże zastosowanie nauki z VR.

PEŁNA EKSPOZYCJA W REALU

Krótki lot, wieża widokowa, kontakt z dorosłym psem.
Wariantowość kontekstów — profilaktyka nawrotu.

Klucz: VRET to *nie gra* — to kontrolowane środowisko terapeutyczne. Mózg reaguje na VR fizjologicznie tak, jak na sytuację realną (tętno, oddech, pocenie). W Polsce VRET dostępna m.in. w VRET Lab Wrocław i wybranych klinikach prywatnych; konsumenckie aplikacje (Psious, oVRcome, Limbix) wymagają tylko podstawowych gogli VR. Optymalna ścieżka: 3-6 sesji VRET → pierwszy kontakt z realnym bodźcem → pełna ekspozycja in vivo.